Établissement

Médecin

PROTOCOLE MÉDICAL PRÉÉTABLI — AS · AES · ÉDUCATEURS

Trachéotomie : canule bouchée ou retirée

Personne trachéotomisée qui respire mal, canule bouchée ou sortie (adulte, enfant ; MAS, FAM, IEM) : appeler, aspirer si formé, ne pas recanuler.

URGENCE VITALE → APPEL 15 IMMÉDIAT · ne respire pas ou respire mal, lutte, cyanose, ne peut plus parler, SpO2 qui baisse, saignement de la trachéotomie, canule sortie.

1 · Je sécurise

- **Appeler l'IDE** immédiatement ; détresse ou canule sortie : **15 en même temps**.
- Personne assise ; matériel de secours du lit à portée (canules, aspiration, BAVU).
- Retirer la **valve phonatoire** ou le bouchon s'il y en a un.

2 · J'observe et je mesure

- Respire-t-elle ? Bruits, sifflement, lutte, couleur des lèvres ; SpO2 (AS/AP).
- Canule **en place**, **déplacée** ou **sortie** ?
- **Laryngectomie** ? La personne ne respire **que** par l'orifice.
- Trachéotomie **récente (< 10 jours)** ? (fiche trachéotomie) : le dire à l'IDE et au 15.

3 · J'agis

- Canule bouchée, orifice cicatrisé : **aspiration endotrachéale** (AS/AP formé).
- Canule interne : la retirer si la personne en a une et si vous êtes formé ; la garder.
- Canule sortie : **orifice dégagé**, rien posé dessus ; garder la canule pour l'IDE.
- Ne respire plus : protocole « Arrêt cardio-respiratoire ».
- Préparer pour l'IDE : canule de même taille et inférieure, aspiration, O2, BAVU.

Je ne fais pas

- **Réintroduire la canule** (geste IDE ou médecin).
- **Mettre l'oxygène** ou régler le débit (geste IDE).
- Forcer une sonde d'aspiration qui bute ; aspirer sur un orifice non cicatrisé.
- Couvrir l'orifice d'une personne laryngectomisée.

J'alerte

Appel 15 immédiat si :

- Détresse respiratoire, cyanose, SpO2 < 90 % (ou sous la cible fixée par le médecin).
- **Canule sortie** : 15 en parallèle de l'IDE.
- Canule toujours bouchée après aspiration ; saignement par la trachéotomie.

J'appelle l'IDE (à défaut : médecin d'astreinte ou DOTR) si :

- **Tout problème de canule**, même si la personne va mieux.
- Sécrétions plus abondantes, épaisses ou sanglantes ; fièvre ≥ 38 °C.
- Cordon de fixation lâche, canule qui bouge, alarme du ventilateur.

Je surveille et je trace

- Respiration, SpO2, couleur, conscience jusqu'à l'arrivée de l'IDE ou du 15.
- Tracer : heure, événement, gestes faits, qui a été prévenu, SpO2.
- À chaque poste : matériel de secours au lit complet ; manque → IDE.

Mention de sécurité

Détresse : 15 et IDE en même temps. L'AS/AP formé aspire sur une trachéotomie cicatrisée ; personne d'autre que l'IDE ou le médecin ne recanule ni ne met l'oxygène.

Fait à : ..... Le : ..... / ..... / .....

Signature :

Vision Moderne de la Santé

Docs On The Road
Construisons ensemble une santé qui vient à vous.

Références : Arrêté du 26/06/2026 (actes), art. 2 B (aspiration endotrachéale AS/AP sur orifice cicatrisé) et art. 4 II (changement de canule) ; HAS, Flash sécurité patient « Trachéo, quand la vie ne tient qu'à un tuyau » (02/2024) ; SPLF, procédures GAVO2 trachéotomie (08/2021) ; protocole DOTR IDE « Trachéotomie : canule bouchée ou retirée (IDE) ».

Réf. DOTR-AS-TRACH | Version 1.0 – 10/2026 | Applicable après signature médicale | Révision au plus tard 12 mois après signature